

FACULTE DE MEDECINE IBN EL JAZZAR DE SOUSSE

COURS DE RESIDANAT

Asthme de l'enfant

Etiopathogénie,

Physiopathologie, Diagnostic,

Traitement

Dr Ines GHANNOUCHI

*Laboratoire Physiologie
et Explorations
Fonctionnelles*

*Année universitaire
2025-2026*

1. Le déficit ventilatoire obstructif proximal est définie par :

- A. Une diminution du rapport VEMS/CVF
- B. Une diminution du VEMS
- C. Une augmentation de la CVF
- D. Une élévation des résistances bronchiques
- E. Une augmentation du rapport VEMS/CV

Réponse :

2. Au cours de la maladie asthmatique on peut observer :

- A. Une élévation des résistances bronchiques
- B. Une obstruction bronchique totalement réversible
- C. Une diminution de la CPT
- D. Une spirométrie normale
- E. Une hyperréactivité bronchique

Réponse :

3. Le système nerveux non adrénérergique non cholinergique (NANC) :

- A. Est exclusivement bronchodilatateur
- B. Est bronchodilatateur par la libération du peptide intestinal vasoactif (VIP)
- C. Est bronchodilatateur par la libération de la substance P (SP)
- D. A pour neuromédiateur le monoxyde d'azote (NO)
- E. Entraîne une hypersécrétion de mucus par la libération de tachikines

Réponse :

4. Le système nerveux parasympathique :

- A. Est responsable du tonus de base du muscle lisse bronchique
- B. Est bronchodilatateur
- C. A pour médiateur la noradrénaline
- D. Agit au niveau du muscle lisse bronchique via ses récepteurs muscariniques
- E. Induit un rétrocontrôle positif au niveau de la jonction neuro-musculaire bronchique

Réponse :

5. On observe une bronchoconstriction :

- A. Sous l'effet du monoxyde d'azote
- B. Au cours de l'asthme
- C. Sous l'action du système nerveux sympathique
- D. Sous l'effet de la métacholine
- E. Sous l'effet de la neurokinine A

Réponse :

6. Le muscle lisse bronchique :

- A. Est riche en fibres sympathiques adrénergiques
- B. Se contracte sous l'action de l'adrénaline
- C. Se contracte sous l'action de l'atropine
- D. Est innervé directement par des fibres parasympathiques

E. A une régulation exclusivement nerveuse

Réponse :

7. QROC :

Un patient âgé de 11 ans suivi pour une allergie aux acariens. Il consulte pour une toux quinteuse associée à des épisodes de dyspnées sifflantes paroxystiques surtout nocturnes.

Une spirométrie a été réalisée et a montré: VEMS/CVF à 0,71 (LIN : 0.75 ; z-score= -2,22) ; VEMS à 1,93 l (LIN : 1,71 ; z-score= -0,70) et CVF à 2,72 l (LIN : 1.98 ; z-score= 0,98).

L'exploration fonctionnelle respiratoire montre :

- A. Un déficit ventilatoire obstructif distal
- B. Un déficit ventilatoire restrictif
- C. Un déficit ventilatoire obstructif proximal
- D. Des signes évoquant une restriction
- E. Une exploration fonctionnelle normale

Réponse :

Un test de réversibilité lui a été demandé. Les résultats post bronchodilatation étaient comme suit : VEMS/CVF à 0,76; VEMS à 2,25 l (augmentation de 320 ml et 16% par rapport à la valeur pré bronchodilatateur) et CVF à 2,95l (augmentation de 230 ml et 8% par rapport à la valeur pré bronchodilatateur).

Le test de réversibilité montre :

- A. Une réversibilité totale
- B. Une réversibilité partielle
- C. Une non réversibilité
- D. Une élévation de la CVF de plus de 12% et 200 ml par rapport à la valeur théorique
- E. Une élévation du VEMS de plus de 12% et 200 ml par rapport à la valeur initiale

